

Neumonía atípica

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David - 2019

TIPs 2015 módulo 8

Libro Azul de Infectología Pediátrica 2012

Se define como neumopatías atípicas a aquellas neumonías que no siguen un curso clínico o radiológico habitual, para diferenciarlas de las que son producidas por los agentes bacterianos clásicos.

Agente causal según frecuencia

- Virus
 - VSR
 - Parainfluenza
 - Adenovirus
 - Metapneumovirus
 - Coronavirus
 - Bocavirus
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia trachomatis* (neumonía afebril del lactante)
- *Pneumocystis jiroveci*

Agentes de infección respiratoria baja y la edad del niño

Agente	Edad		
	< 6 meses de edad	entre 6 meses - 5 años	más de 5 años
VSR	+++	++++	+
Adenovirus (ADV)	++	+++	+++
Parainfluenza 1,2,3	+	++	++
<i>M pneumoniae</i>	-	++	++++
<i>C trachomatis</i>	++++	+	-
<i>C pneumoniae</i>	?	?	+++
<i>Pneumocystis jiroveci</i> *	+	++	+
<i>Coxiella burnetii</i>	+	+	+

Correlación etiología-clínica radiología-laboratorio

	NAC típica	NAC atípica viral	NAC atípica (Mycoplasma, Chlamydia)
Edad	Cualquier edad, principalmente < 3- 5 años	< 3- 4 años	> 3-4 años
Inicio, estado general	Brusco, afectado	Insidioso, conservado	Insidioso, conservado
Antecedentes fliares	No	Simultáneos	Distantes
Fiebre, tos, síntomas asociados	>39, productiva, Raros (herpes labial)	<39, productiva + -, Conjuntivitis, mialgias	<39, irritativa Cefaleas, mialgias
Auscultación	Crepitantes localizados, hipoventilación	Crepitantes y sibilancias bilaterales	Crepitantes y/o sibilancias uni o bilaterales
Radiografía	Condensación con o sin derrame	Infiltrado intersticial, atelectasia	Infiltrado intersticial, menos frecuente condensación
hemograma	Leucocitosis con neutrofilia	variable	Suele ser normal
PCR / PCT	>80-100 / >2	<80 / <2	<80 / <2

Clínica

Clásicamente es precedida por uno o dos días de rinitis, tos seca, pérdida de apetito y febrícula. Posteriormente se hacen evidentes los signos respiratorios bajos, con taquipnea, tiraje, taquicardia, tos seca más intensa, decaimiento y fiebre/febrícula.

Radiografía de tórax

Condensación no lobar e importante disociación clínico-radiológica (predominio de las manifestaciones radiológicas sobre los hallazgos auscultatorios), hay afectación en forma difusa y opacidades perihiliares e intersticiales, aunque puede haber formas localizadas, también pueden observarse opacidades en parche con áreas de atelectasias.

Analítica

En general no requieren, el hemograma muestra habitualmente leucocitosis moderada con fórmula variable y los reactantes de fase aguda se mueven discretamente.

Métodos diagnósticos

Virus:

Test de látex rápido para VSR de secreciones nasofaríngeas

Panel virológico de secreciones nasofaríngeas: VSR, parainfluenza, influenza, adenovirus.

***Mycoplasma pneumoniae*:**

- Serológicos por inmunofluorescencia indirecta (IFI) y prueba de ELISA permiten detectar en sangre la presencia de anticuerpos de IgG e IgM específica. Debemos tener en cuenta que la IgM puede presentar títulos falsos positivos hasta en el 20% de los casos y pueden estar relacionados a infecciones pasadas o pacientes con pancreatitis.
- PCR: permite hacer el diagnóstico en el episodio agudo a partir de una muestra tomada por aspirado nasofaríngeo. Dado que el micoplasma puede permanecer en secreciones respiratorias por un largo período de tiempo siempre deberemos correlacionar su presencia con el cuadro clínico que presenta el paciente. En los pacientes inmunocomprometidos la serología puede ser negativa, en estos casos la PCR es de mayor utilidad.

***Chlamydia trachomatis*:**

PCR e IF directa en secreciones nasofaríngeas

Mycoplasma pneumoniae

Bacteria cocoide, filamentosa o estrellada de pequeño tamaño, que carece de pared celular perteneciente a la familia de *Mycoplasmataceae*.

Epidemiología

Puede ser el responsable hasta el 40 de las neumonías de la comunidad en niños mayores de 5 años.

La mayoría de los casos se pueden observar en el otoño y verano, pero se puede presentar en cualquier período del año.

Compromete más a los adolescentes y adultos jóvenes, pero en períodos de epidemia, que se presentan cada 3 a 4 años, afecta a todos los grupos etarios incluso a niños menores de 4 años.

La evolución en la mayoría de los casos es de presentación benigna y autolimitada, La enfermedad no deja inmunidad duradera, pero sí en forma parcial, pudiendo repetirse la enfermedad en un mismo paciente.

De presentarse una recaída la forma de presentación es más leve.

Fisiopatología

El contagio se produce de persona a persona, la vía de transmisión es respiratoria a través de gotas de Pfluge que se diseminan con la tos, al hablar o estornudar.

Una vez inhalado el germen afecta a las células epiteliales ciliadas respiratorias y produce una toxina (ADP ribosiltransferasa) afectando el surfactante, provocando endocitosis, cilioestasis, fragmentación nuclear y producción de citoquinas proinflamatorias y reacción antiinflamatorias comprometiendo de esta forma la vía aérea. Existe también por acción del micoplasma la estimulación de linfocitos T y B con importante formación de autoanticuerpos que pueden reaccionar en distintas formas sobre el huésped comprometiendo así diferentes órganos choque.

Al carecer de pared celular no se ve afectado por los antibióticos betalactámicos, penicilinas y glicopéptidos.

Al tratarse de un germen intracelular estaría protegido de la acción de los anticuerpos, esto ayudaría a la permanencia del germen en el hospedador por largos períodos de tiempo.

Cuadro clínico

El compromiso respiratorio bajo es el foco principal, comienza insidiosamente con:

- Fiebre.
- Decaimiento.
- Cefaleas.
- Taquipnea.
- Rales diseminados
- Tos seca de comienzo irritativa con escasa eliminación de secreciones.

Se puede presentar con *rash* exantemático maculopapuloso hasta en un 15% de los casos.

El compromiso pleural puede ser observado en el 10 a 15% de los casos.

La rinitis, la sinusitis y la laringitis son poco frecuentes; esta sintomatología si se presenta, nos debería hacer pensar en otros agentes etiológicos, ejemplo virus.

En menor frecuencia podemos observar compromiso por mecanismos autoinmunes:

- Anemia hemolítica, trombocitopenia, anemia autoinmunitaria.
- Guillan Barre, encefalomiелitis desmielinizantes, polirradiculoneuritis, neuritis óptica, uveítis.
- Mialgias-rabdomiolisis.
- Compromiso dermatológico tipo Stevens Johnson y necrosis tóxica ampollar.
- Eritema multiforme.
- Nefritis intersticial, nefropatía IgA.

Pueden coexistir en un mismo proceso un virus respiratorio y una bacteria (si el virológico es positivo se debe compatibilizar siempre con la clínica).

Tratamiento

- Azitromicina (10 mg/kg por 1 día, seguido de 5 mg/kg/día hasta completar 5 días)
- Claritromicina (15 mg/kg/día por 7 días)
- Eritromicina (20-50 mg/kg/día por 10-14 días)

La administración profiláctica de la azitromicina disminuye la tasa de transmisión y la aparición de los síntomas.

Teniendo en cuenta, que la contagiosidad de esta enfermedad es relativamente baja, las medidas de aislamiento suelen ser efectivas para controlar la diseminación de la enfermedad.